



Ministério da Saúde

Urgencia Nº: XX Data Urg.: xx-xx-xxxx xx:xx:xx
Proc.: XXXX Identificação N. Utente: XXXX
Nome: XXX
Data Nasc.: XX/XX/XXXX (XX Anos) Prof XXXX Sexo: XXX
Morada: XXXX
Localidade: XXXXx Telefone: XXXX

Médico Família

Centro de Saúde: XXXXX
Médico: XXXXXX

Outros Dados

Causa : XXXXXX Proveniência: XXXXXx
Subsistema: XXXXXX
Observações: XXXX

Triagem

Data / Hora da Triagem: XXXXX
Discriminador: xxxxx

Fluxograma : XXXX

Prioridade Clínica

Temperatura: Dor: XX

Glasgow: XXXXX

PEFR: Freq. Resp.: PA: /

Glicémia: Corpos cetónicos: Freq. card.: Ritmo de pulso:

Oxi. per.:

Mobilidade: XXXXXx

Especialidade: XXXXX Grupo: XXXXX Sala: XXXX

Queixa: XXXXX

Justificação Via Verde:

Triador: XXXXXXXX Nº. Mecanográfico: XXXX Ass.: _

Observações Médicas

20-Jan-2026 10:18:00 Dr(a). Miguel Tavares Correia (HUC-URG_MEDICA)

Trazido por familiar por febre, tosse produtiva c/ expectoração mucopurulenta amarelada e mal-estar geral c/ 48h evolução. Refere astenia, diminuição da ingestão hídrica/alimentar e dispneia ligeira ao esforço habitual. Nega dor torácica pleurítica, hemoptises, vômitos, diarreia ou sintomas urinários. Sem contactos conhecidos c/ doentes respiratórios. Antecedente de PAC em 12/2024, c/ recuperação completa.

AP: FA permanente sob varfarina e digoxina; HTA; DRC 3a; gonartrose bilateral; défice cognitivo ligeiro; fractura colo fémur D pós-cirúrgica 09/2025. Anemia normocítica ligeira habitual no contexto de DRC. Sem alergias medicamentosas conhecidas.

MH: varfarina conforme INR, digoxina 0,125 mg id, amlodipina 5 mg id, furosemida 20 mg id, paracetamol 1 g SOS.

À observação consciente, colaborante, algo prostrado, orientado na pessoa e local; sem confusão aguda evidente. Mucosas secas. Eupneico em repouso, taquipneia ligeira à fala. Sem uso músculos acessórios. TA 128/68 mmHg, FC 96 bpm, irregular, FR 22 cpm, T 38,4°C, SpO2 92% ar ambiente; glicemia capilar 126 mg/dL. AC: sons cardíacos arrítmicos, sem sopros audíveis. AP: murmúrio vesicular globalmente mantido, diminuído na base D, ferveores crepitantes inspiratórios focalizados em terço inferior hemitórax D; sem sibilos. Abdómen plano, depressível, indolor, sem massas ou defesa. Sem edemas periféricos relevantes. Gêmeos macios, indolores. Sem exantema. Sem sinais focais neurológicos.

Colhidas hemoculturas x2 previamente a ATB. Testes rápidos SARS-CoV-2/influenza A/B negativos.

Analítica: Hb 10,8 g/dL, VGM 91 fL, leucócitos 16,9 x10⁹/L, neutrófilos 14,8 x10⁹/L, plaquetas 212 x10⁹/L. PCR 186 mg/L; PCT 0,42 ng/mL. Ureia 78 mg/dL, creatinina 1,71 mg/dL (basal referido ~1,35-1,45 mg/dL), TFG_e 39 mL/min/1,73m²; Na 134 mmol/L, K 4,3 mmol/L, Cl 98 mmol/L. AST 24 U/L, ALT 18 U/L, BT 0,7 mg/dL. Glicemia 132 mg/dL. INR 2,46, compatível c/ anticoagulação terapêutica. Gasimetria arterial AA: pH 7,43, pCO₂ 35 mmHg, pO₂ 66 mmHg, HCO₃⁻ 23 mmol/L, lactato 1,4 mmol/L. Sumária urina sem leucocitúria/nitritos; densidade 1,025, compatível c/ hipohidratação.

Rx tórax PA/perfil: opacidade alveolar mal definida, predominantemente no segmento basal posterior do lobo inferior direito, c/ broncograma aéreo, compatível c/ foco de condensação pneumónica. Discretas bandas atelectásicas bibasais. Sem derrame pleural. Sem pneumotórax. Silhueta cardíaca discretamente aumentada, sem sinais de edema pulmonar agudo.

Quadro compatível c/ pneumonia adquirida na comunidade, lobo inferior D, c/ resposta inflamatória sistémica, hipoxemia ligeira e agravamento transitório da função renal, provavelmente pré-renal por reduzida ingestão/perdas insensíveis associadas a febre. Hemodinamicamente estável, sem critérios de choque ou necessidade de suporte ventilatório invasivo. CURB-65 elevado por idade e ureia, acrescendo fragilidade, DRC e dificuldade previsível em manter hidratação/vigilância domiciliária.

Iniciada ceftriaxone EV + azitromicina EV após colheitas microbiológicas. Bólus cauteloso SF 0,9% 500 mL, seguido de perfusão 1000 mL/12h c/ reavaliação clínica e balanço hídrico, atendendo a idade/antecedente de diurético. Oxigenoterapia por cânula nasal 1 L/min, SpO₂ pós-O₂ 95%. Paracetamol 1 g EV c/ apirexia subsequente. Suspender temporariamente furosemida; manter vigilância de função renal, ionograma e INR, dado contexto infeccioso e potencial interacção ATB-varfarina. Manter digoxina; reavaliar FC e função renal. Amlodipina condicionada a perfil tensional.

Contactado Serviço de Medicina Interna. Aceite para internamento de curta duração, para ATB EV, suporte hídrico, vigilância respiratória e reavaliação analítica.

Notas de Enfermagem

10:32 – Admitido em cadeira de rodas, acompanhado por familiar. Febril, consciente, colaborante. SpO₂ 92% AA; iniciada O₂ CN 1 L/min, SpO₂ 95%. Acesso venoso periférico 20G MSD, permeável. Colhidas análises, gasimetria e hemoculturas x2. Administrado paracetamol 1 g EV, ceftriaxone 2 g EV e azitromicina 500 mg EV, sem reacção adversa imediata.

12:15 – Após hidratação EV, TA 122/64 mmHg, FC 88 bpm irregular, FR 19 cpm, T 37,6°C, SpO2 95% c/ O2 1 L/min. Sem agravamento de dispneia, sem dor torácica. Transferido em condições estáveis.

Diagnósticos

(J18.9) - Pneumonia adquirida na comunidade, base pulmonar direita

(N17.9) - Agravamento agudo da função renal, provável componente pré-renal

(R09.02) - Hipoxemia ligeira

(I48.2) - Fibrilhação auricular permanente sob anticoagulação

Medicação

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco

20/01/2026 10:45 | 20/01/2026 10:45 | 20/01/2026 10:45 | Paracetamol 1 g EV

20/01/2026 11:20 | Em curso | 20/01/2026 11:20 | Ceftriaxone 2 g EV

20/01/2026 11:35 | Em curso | 20/01/2026 11:35 | Azitromicina 500 mg EV

20/01/2026 10:50 | 20/01/2026 12:50 | Em curso | Cloreto de sódio 0,9% EV, 1500 mL

20/01/2026 10:35 | Em curso | Em curso | Oxigénio por cânula nasal 1 L/min

MCDT Requisitados / Procedimentos Efectuados

M10801 – Radiografia tórax PA e perfil: opacidade alveolar mal definida no território basal posterior do LID, c/ broncograma aéreo, sugestiva de condensação pneumónica. Sem derrame pleural associado. Sem pneumotórax. Discretas bandas atelectásicas bibasais.

L10001 – Hemograma completo: leucocitose $16,9 \times 10^9/L$ c/ neutrofilia $14,8 \times 10^9/L$; Hb 10,8 g/dL, normocítica; plaquetas $212 \times 10^9/L$.

L10016 – Bioquímica/inflamação: PCR 186 mg/L, PCT 0,42 ng/mL; creatinina 1,71 mg/dL, ureia 78 mg/dL, ligeiro agravamento face ao basal conhecido; ionograma sem alterações major.

L10042 – Coagulação: INR 2,46 sob varfarina.

L10112 – Gasimetria arterial: hipoxemia ligeira, pO2 66 mmHg AA, sem acidose ou hiperlactacidémia.

M41002 – Hemoculturas periféricas x2 colhidas antes de antibioterapia; resultados pendentes.

M41016 – PCR SARS-CoV-2 e teste influenza A/B: negativos.

L10221 – Sumária de urina: sem sinais de infecção urinária; urina concentrada.

Destino do Doente

Data: 20/01/2026 12:35

Destino: Internamento Medicina Interna – curta duração/observação, em maca, estável, sob O2 CN 1 L/min e hidratação EV.

Médico: Dr. Miguel Tavares Correia